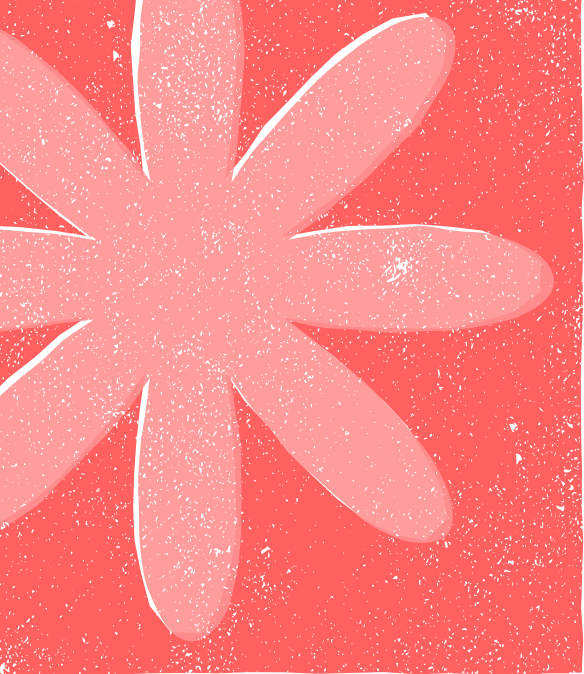




# **Disforia de Gènere**

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE  
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
UMECIT

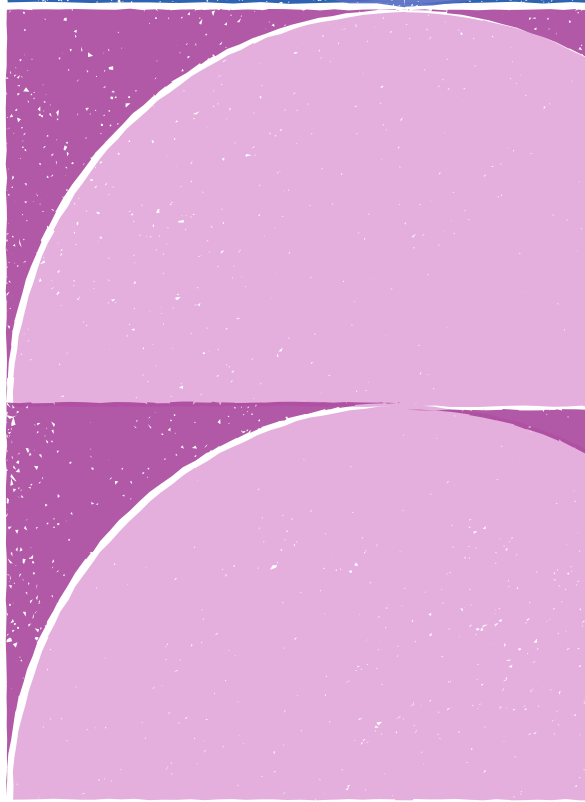
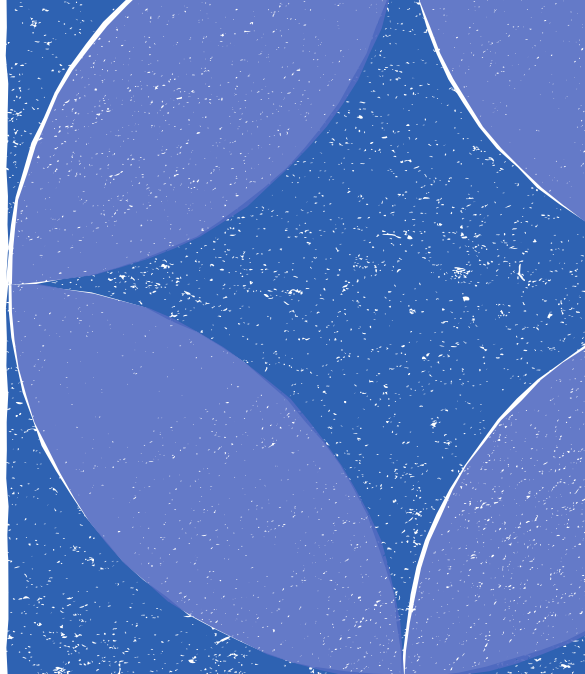
MAESTRÍA PSICOLOGÍA CLÍNICA

PSICOPATOLOGÍA I NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

ESTUDIANTE: NÈMESIS M. LÒPEZ G.

PROFESORA:  
DRA. AELEN LÒPEZ

MAYO 2026



# Frase

**Ser transgénero no es solo una transición medica;  
es descubrir quien eres.  
Janet Mock.**



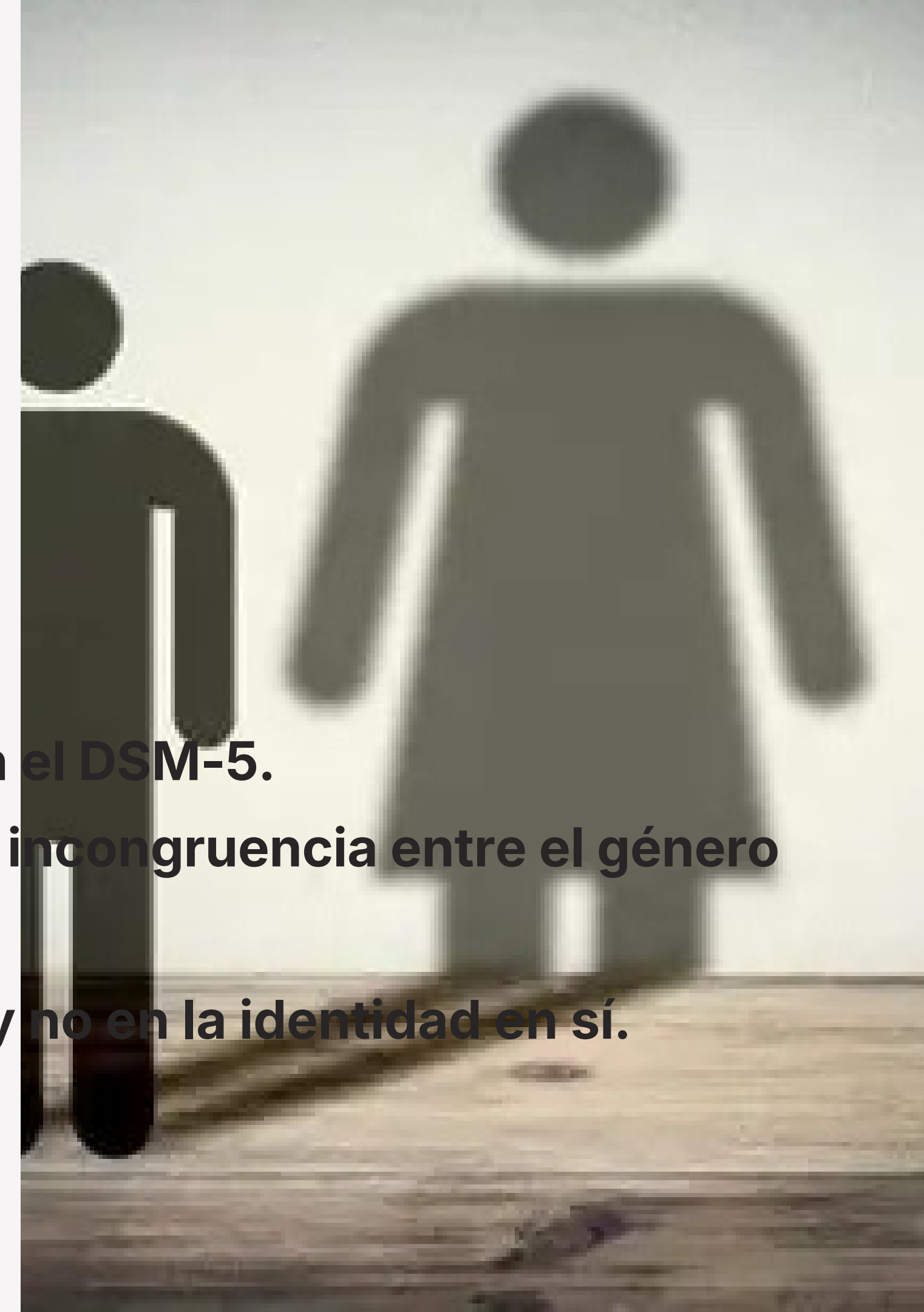
# Definición General

**La disforia de género es una condición descrita en el DSM-5.**

**Se caracteriza por un malestar intenso debido a la incongruencia entre el género sentido y el asignado al nacer.**

**El diagnóstico se enfoca en el sufrimiento clínico y no en la identidad en sí.**

**No todas las personas trans presentan disforia.**



# DSM-5-TR: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DISFORIA DE GÉNERO

| CRITERIO                                                                                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                            | DETALLES CLÍNICOS                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1. DURACIÓN                 | Incongruencia marcada entre el género experimentado y el sexo asignado durante mínimo 6 meses.                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>El malestar y la incongruencia deben ser persistentes.</li></ul>                                        |
|  2. MANIFESTACIONES          | Deben presentarse 2 o más de las siguientes manifestaciones.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Requiere al menos dos criterios para establecer el diagnóstico.</li></ul>                               |
|  3. CARACTERÍSTICAS SEXUALES | Malestar significativo con las características sexuales primarias o secundarias propias.                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Puede incluir rechazo o incomodidad intensa con el cuerpo.</li></ul>                                    |
|  4. DESEO CORPORAL          | Deseo de eliminar o modificar las características sexuales propias.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Incluye el deseo de cambios físicos para que el cuerpo se alinee con el género experimentado.</li></ul> |
|  5. IDENTIDAD DE GÉNERO    | Deseo intenso de pertenecer al otro género (o a un género alternativo diferente al asignado).                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>El deseo debe ser persistente y claro.</li></ul>                                                        |
|  6. TRATO SOCIAL           | Deseo de ser tratado como una persona del otro género.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Incluye el deseo de vivir y ser reconocido socialmente en ese género.</li></ul>                         |
|  7. CONVICCIÓN INTERNA     | Convicción de tener los sentimientos, reacciones y características típicas del otro género (o de un género alternativo).               | <ul style="list-style-type: none"><li>Se refiere a la certeza interna de pertenecer a ese género.</li></ul>                                   |
|  8. MALESTAR CLÍNICO       | La condición causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. | <ul style="list-style-type: none"><li>El diagnóstico se centra en el malestar y no en la identidad de género en sí misma.</li></ul>           |



**NOTA IMPORTANTE:** El diagnóstico de disforia de género no patologiza la identidad de género. Se centra en el malestar clínicamente significativo asociado a la incongruencia entre el género experimentado y el sexo asignado.

# Criterios en Adultos

## **Deseo de Eliminación**

Incluye deseo intenso de eliminar características sexuales propias.

## **Deseo de Posesión**

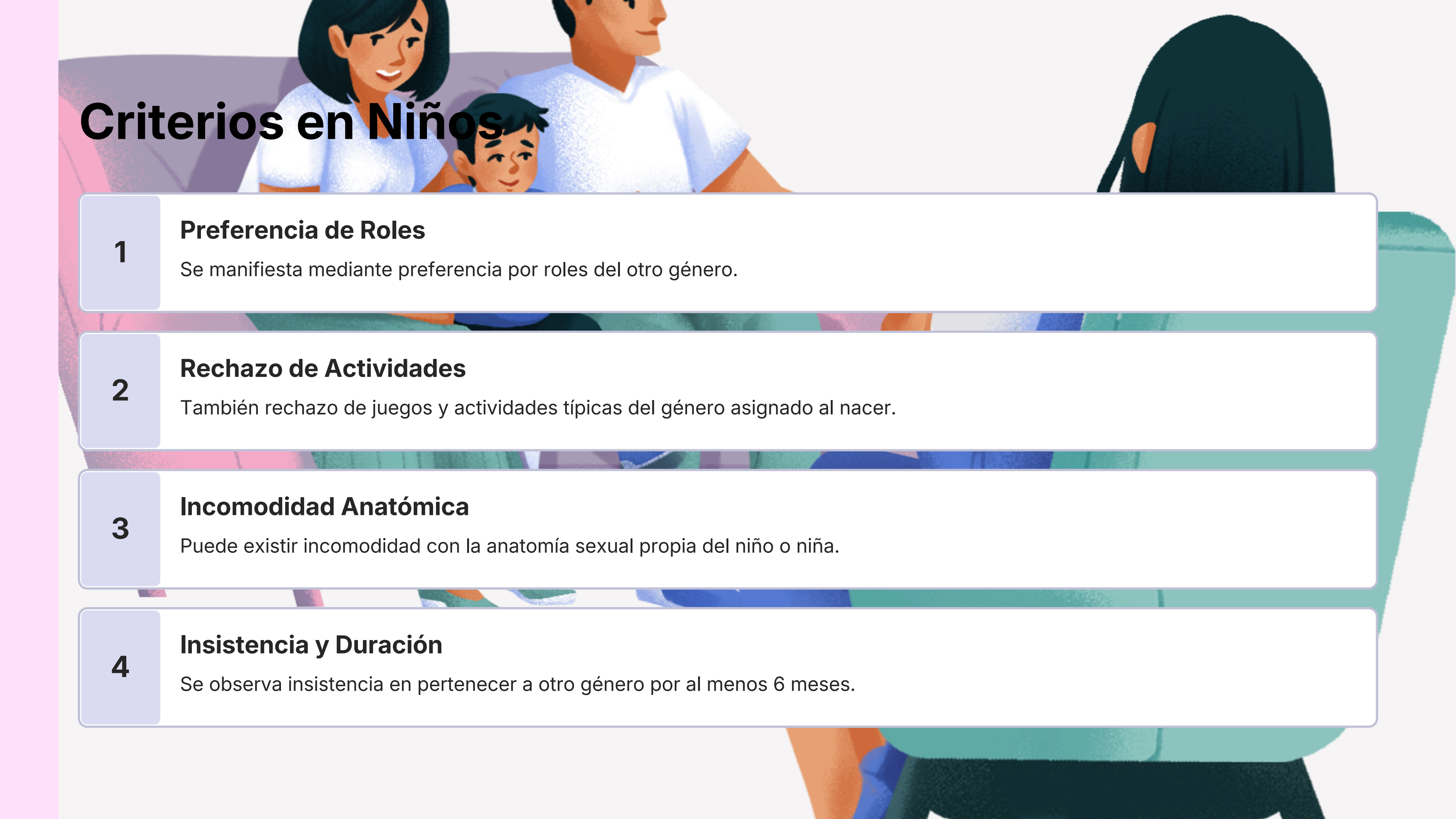
También el deseo de poseer características del género opuesto.

## **Convicción de Género**

Existe una fuerte convicción de pertenecer a otro género con incomodidad en roles sociales asignados.

## **Persistencia**

El malestar debe ser persistente y significativo para cumplir criterios diagnósticos.



# Criterios en Niños

1

## **Preferencia de Roles**

Se manifiesta mediante preferencia por roles del otro género.

2

## **Rechazo de Actividades**

También rechazo de juegos y actividades típicas del género asignado al nacer.

3

## **Incomodidad Anatómica**

Puede existir incomodidad con la anatomía sexual propia del niño o niña.

4

## **Insistencia y Duración**

Se observa insistencia en pertenecer a otro género por al menos 6 meses.

# Estadísticas Internacionales

## 0.014%

**Prevalencia en adultos asignados hombres (OMS)**

Estimación máxima según datos internacionales disponibles.



**Aumento de casos**

Mayor visibilidad ha incrementado los casos reportados en años recientes.

Según la OMS, la prevalencia estimada varía entre 0.005% y 0.014% en adultos asignados hombres; en personas asignadas mujeres la cifra es menor.

La OPS destaca la importancia del acceso a servicios de salud mental.

Existe subregistro significativo en muchos países de la región.





# Estadísticas en Latinoamérica y Panamá

En Latinoamérica hay escasez de datos oficiales sobre disforia de género.

Organizaciones como la OPS reportan barreras importantes en el acceso a salud mental.

En Panamá no existen estadísticas oficiales completas sobre esta condición.

Se reconoce un aumento en consultas psicológicas relacionadas con identidad de género.

La estigmatización sigue siendo un factor limitante que requiere mayor investigación local.

# CUADRO COMPARATIVO: DSM-5-TR vs CIE-11

| CRITERIO                                                                                               | DSM-5-TR                                                                                                                                     | CIE-11                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  CLASIFICACIÓN        |  Trastorno mental                                         |  Condición de salud sexual       |
|  ÉNFASIS              |  Malestar clínico                                         |  Incongruencia de género         |
|  TERMINOLOGÍA         |  “Disforia de género”                                     |  “Incongruencia de género”       |
|  ESTIGMATIZACIÓN    |  Mayor carga estigmatizante                             |  Reduce la estigmatización     |
|  ACCESO A SERVICIOS |  Requiere diagnóstico mental                            |  Facilita acceso a servicios   |
|  COINCIDENCIA       |  Necesidad de atención clínica                          |  Necesidad de atención clínica |
|                     | Ambos sistemas coinciden en la necesidad de una atención clínica adecuada, ética y rigurosa, centrada en el <b>bienestar de la persona</b> . |                                                                                                                     |

# Diferencias Clave entre DSM-5-TR y CIE-11

## DSM-5-TR

Mantiene un enfoque psicopatológico centrado en el malestar como criterio diagnóstico central.

## CIE-11

Reduce la estigmatización al reclasificar la condición fuera de los trastornos mentales.

Ambos requieren evaluación clínica rigurosa y atención especializada.

El CIE-11 busca facilitar el acceso a servicios sin requerir diagnóstico de trastorno mental.

La diferencia principal radica en el enfoque conceptual de la condición y su impacto social.





EVIDENCIA CIENTÍFICA

## Investigación Reciente (2020–2026)

Un estudio de 2022 en *The Lancet Psychiatry* analizó salud mental en personas trans.

Se encontró mayor riesgo de ansiedad y depresión en esta población.

Sin embargo, el acceso a apoyo psicológico reduce significativamente estos riesgos.

La afirmación de género mejora la calidad de vida de manera demostrable.

El estudio resalta la importancia del acompañamiento clínico especializado.



**Referencia:** The Lancet Psychiatry (2022) —

<https://www.thelancet.com/journals/lanpsy>

# Implicaciones Clínicas

El abordaje clínico debe ser multidisciplinario e integral.  
Incluye psicoterapia afirmativa y apoyo psicosocial continuo.  
No se busca "cambiar" la identidad del paciente en ningún caso.  
Se prioriza el bienestar emocional y el funcionamiento cotidiano.  
Es clave evitar prácticas no éticas como las terapias de conversión.

## Enfoque Multidisciplinario

Psicología, psiquiatría, endocrinología y trabajo social deben coordinarse en el plan de atención.

## Psicoterapia Afirmativa

El modelo afirmativo valida la identidad del paciente y fortalece su bienestar psicológico.

## Ética Profesional

Las terapias de conversión están contraindicadas y constituyen una práctica no ética y dañina.

# Tratamiento

01

## Evaluación Psicológica

Diagnóstico integral y establecimiento del plan terapéutico personalizado.

02

## Psicoterapia de Apoyo

Acompañamiento psicológico continuo centrado en bienestar y autonomía.

03

## Intervención Hormonal

Terapia hormonal supervisada por endocrinología cuando el paciente lo requiera.

04

## Cirugía (si aplica)

Procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en casos seleccionados.



# Personas Famosas

## Figuras Públicas Trans

Elliot Page, Laverne Cox y Caitlyn Jenner han visibilizado la experiencia trans.

Su impacto ha sido relevante en la salud pública y la percepción social.

Han contribuido a la aceptación y reducción del estigma social.

Su visibilidad ha inspirado a muchas personas a buscar ayuda.

Son referentes de resiliencia y afirmación de identidad.



Video



link:

<https://www.youtube.com/watch?v=Im4HcYPJ1Kw>